

Répétitoires Skills

Urgences

1. Regarder la scène, mettre des gants si on en a, regarder s'il y a des prises
banches, si est sur un passage piéton, sécuriser la scène
2. Appeler le 144
3. Prendre le pouls carotidien, moins de 10 sec
4. Regarder si est réactif, il faut aller vite
5. Il faut absolument faire le CAB
6. Si on doit faire une PLS : utiliser les bras de levier
7. Massage cardiaque : 30 compressions et 2 insufflations : bien positionner les
mains au milieu du sternum et bien relâcher le thorax
8. Manœuvre de Esmach : s'il y a un trauma du rachis
9. Défibrillation : ne pas oublier d'allumer, Attention surface métallique
10. CABD -> circulation, airway, breathing, défibrillation
11. Savoir faire le DD des douleurs thoraciques ou des douleurs aiguës
12. TTT infarctus : MONA (Morphine, oxygène, nitrés, aspirine)
13. RED FLAGS abdos : tous les troubles faisant penser à une cause vasculaire :
paramètre vitaux
14. G-Fast : Fait un point pour chaque lettre : Gaze, face, arm, speech/swallow,
time
15. AVC : alarmer, rassurer, position couchée
16. Glasgow : essentiellement traumatique : SAVOIR PAR CŒUR
 - a. Le glasgow ne rentre pas dans le CAB -> on le fait si le type est stabiliser
hémodynamiquement par exemple
17. Triangle d'évaluation pédiatrique : apparence, état circulatoire, travail
respiratoire

GALS

C'est un test de dépistage de tous les problèmes rhumato, ostéo-articulaire

Gait, Arms, Legs, Spins

Si on a un doute, on va approfondir. On continue le GALS et on dit qu'on va avertir
le médecin et qu'il va faire des recherches plus approfondies

1. 3 questions à poser
 - a. Douleurs, raideurs au niveau des muscles ou des articulations ou du
dos ?
 - b. Arrive à s'habiller et se déshabiller sans difficultés ?
 - c. Peut descendre et monter les escaliers ?
2. Enlever les chaussures et les habits
3. Marche

- a. Observer la symétrie, l'harmonie des mouvements, le ballant des bras, la démarche talons-pointes, longueurs de la foulée, l'inclinaison du bassin
 - b. Chercher un Parkinson, fauchage si hémiparésie, Trendelburg, douleur si claudication (canal lombaire étroit ou artériel), steppage si neuropathie périph (laisse trainer la pointe et doit lever la jambe très haut pour marcher)
4. Inspection : de la tête aux pieds -> dire ce que l'on fait à l'oral
- a. De derrière :
 - i. Epaules : symétriques, inflamm, amyotrophie
 - ii. Dos : scoliose, cyphose,...
 - iii. Bassin : symétrique, atrophie
 - iv. Creux poplité : kyste,...
 - v. Genoux : valgus/varus -> demander de rapprocher les pieds
 - vi. Tendon d'Achille : kystes, ruptures
 - vii. Pieds : sont légèrement en valgus physiologiquement, doit s'enlever si se met sur la pointe des peids
 - b. De côté :
 - i. Dos : Lordose, cyphose, lordose. Si coxarthrose : ont une sorte d'hyperlordose lombaire
 - ii. Genoux : flexum ou hyperextension
 - iii. Pieds et cheville : déformation
 - c. De face :
 - i. Epaules
 - ii. Thorax
 - iii. Bassin : crêtes iliaques à la même hauteur
 - iv. Genoux : épanchements, arthrite, bursite
 - v. Pieds, chevilles : crises de gouttes, hallux valgus
5. Tests fonctionnels de la tête aux pieds
- a. Demander s'il y a des douleurs ou des gênes quand on fait ces différents tests.
 - b. Rachis
 - i. Test de la mobilité :
 - 1. Mâchoire : ouvrir, fermer, bouger de côté
 - 2. Colonne cervicale : tourner la tête, en haut, en bas
 - 3. Colonne lombaire :
 - a. Schobert : prendre 2 marques (L5 (entre les 2 crêtes iliaques) et 10 cm en dessus) -> distance doit augmenter à 15 cm. Si pas -> spondylarthrite ankylosante
 - b. Distance doigts sol : norme de moins de 20 cm
 - c. Inclinaison sur le côté -> doit aller jusqu'au genou
 - d. Tourner, rotation de la colonne
 - c. Membre supérieur :

- i. Mettre les mains derrière la tête de pousser les coudes vers l'arrière : rot int, extension et abduction -> pas de soucis avec la coiffe des rotateurs, neuro,... teste presque tout
 - ii. Palm up : bras à 90°, lever les bras contre la force
 - iii. Extension des coudes : regarder qu'il y ait l'angle avec l'avant-bras qui part latéralement
 - iv. Mains :
 - 1. Examen des 2 faces : observer, palper les loges thénar et hypothénar, demander d'écarter ou serrer les doigts (pour la pronation)
 - 2. Pianotage pour tester la mobilité fines (atteinte pyramidale)
 - 3. Squeeze test : comprimer les métacarpien et si fait mal penser à polyarthrite rhumatoïde
- d. Faire coucher le patient, se mettre à droite
- e. Membre inf :
 - i. Examiner
 - ii. Faire le varus valgus si on l'a pas fait debout : prendre les jambes et les soulever un peu (20°)
 - iii. Mouvements :
 - 1. Flexion hanche : pousser son genou contre son ventre
 - 2. Adduction hanche : pousser sa jambe sur l'autre jambe
 - 3. Abduction hanche : tirer la jambe sur le côté
 - 4. Extension hanche : tourner sur le ventre et monter la jambe
 - 5. Extension genou : demander de tendre la jambe
 - 6. Flexion genou
 - 7. Rotation interne et externe
 - iv. Signes du glaçon pour épanchement du genou

Status de la main

Il faut bien choisir à l'ECOS quel test on fait.

Savoir les os de la main, savoir l'artère radiale et ulnaire (arcade dorsale), innervation (médian, ulnaire et radial) savoir ce qu'ils innervent et la sensi. Attention au tunnel carpien sur la face palmaire.

- 1. Inspection :
 - a. Couleur : érythème palmaire, un doigt blanc
 - b. Cicatrice (tunnel carpien)
 - c. Infection
 - d. Déformation : boutonnière (extension articulation phalangienne prox et flexion IPP), col de cygne (polyarthrite rhumatoïde), nodosité, mallet finger, main en griffe ulnaire, main tombante, rizarthrose (arthrose de la base du pouce)
 - e. Hypotrophie d'une loge : compression d'un nerf

- f. Phlegmon de la gaine des fléchisseurs -> urgence chirurgicale, infection des tendons quand ils passent dans la gaine. N'arrive pas à étendre, bloquée en flexion. Urgence chir.
2. Palpation : faire que du côté pathologique, pas besoin de comparer avec l'autre.
- a. Masses : œdèmes, hématomes, nodosités
 - b. Radius et ulna distal
 - c. Scaphoïde : os qui se casse le plus souvent
 - d. Phalanges, métacarpien et autres os du carpe
 - e. Vasculature : membre froid ou chaud, rouge, turgescence, retour capillaire, pouls
 - f. Innervation : baisse de sensibilité suite à une plaie, ..
 - g. Tubercule de Lister à la face dorsale
 - h. Scaphoïde : Tubercule palmaire du scaphoïde, dans l'axe de l'artère radiale, à travers la tabatière anatomique, le pôle proximale. Si on fait une inclinaison ulnaire et que ça fait mal = fracture scaphoïde
 - i. Bord distal de la tête ulnaire, processus styloïde, bord palmaire de la tête avec les ligaments du TTCC.
 - j. Maladie de Dupuytren : sorte de flexum du dernier doigts, fibrose rétractile de l'aponévrose palmaire
 - k. Ténosynovite sténosante : atteinte des fléchisseurs au niveau des poulies. Épaississement de la gaine synoviale, et il y a une création d'un nodule qui va se coincer dans la gaine et le doigt ne pourra plus bouger. Et une fois qu'il est sorti, le doigt fait un saut. On peut bien le palper
 - l. Kyste synovial du poignet, se fait le plus souvent au niveau radio-carpien. C'est un kyste synovial, souvent pas besoin d'opérer, cela fait rien.
 - m. Sites douloureux : faire à la fin
3. Tests fonctionnels :
- a. Test de la flexion et extension du poignet : passif et actif
 - b. Inclinaison ulnaire et radiale
 - c. Tous les muscles
 - d. Effet ténorèse : faire une extension de la main, et les doigts doivent partir en flexion, et si on fait une extension du poignet, les doigts doivent rester
 - e. Tests rapides nerveux : extension de la main (ulnaire), du pouce (radial), faire le rond (médian)
 - f. Pouce du skieur : ligament latéral du pouce est lésé
 - g. Test de Watson : pour un lig entre le scaphoïde et le lunatum
 - h. Test de Phalen : pour le nerf médian comprimé dans le tunnel carpien. Mettre les deux dos de la main ensemble, laisser pendant une minute et regarder si a des picotements,...
 - i. Test de Tinel : pour le nerf médian dans le tunnel carpien. Picoter le nerf dans son passage.

- j. Test de Drukan : pour le nerf médian dans le tunnel carpien. Appuyer sur le tunnel carpien et maintenir une pression
- k. Signe de Forment : atteinte nerf ulnaire. Mettre un papier entre le pouce et le premier doigt, et si on tire dessus doit garder cette même position et pas faire une flexion du pouce. A ce moment là, le test est positif.
- l. Test de Finkelstein : Tendinite de Cavin. Tendinite chez la maman à force de porter son bébé. Mettre son pouce au milieu des doigts et fermer le poing.
- m. Test de Allen : pour la vascu

Skills pédiatrie

1. Anamnèse
 - a. Actuelle : PQRST : palliation/provocation, qualité/quantité, régions/irradiation, sévérité, temporalité
 - b. Systémique :
 - i. Cardio-pulm : dyspnée, sudations, toux, respi
 - ii. ORL : rhinorrhée, nez bouché, douleurs oreilles
 - iii. Abdos :
 1. Vomissement : en jet ?
 2. Urines : couches ? combien ?
 3. Selles
 - iv. Cutané : rash
 - v. Général :
 1. Fièvre
 2. Poids
 3. Sommeil
 4. Alimentation
 5. Comportement : irritabilité, apathique, jouent comme d'habitude
 - c. Périnatal : si moins de 3 mois
 - i. Gestation, poids, taille, périmètre crânien
 - ii. Evolution de la grossesse
 - iii. Accouchement (voie basse, césarienne, complication)
 - iv. Problèmes dans la périodes néonatale (jusqu'à 28 jours)
 - d. Antécédents perso : appendicite et amygdales
 - e. Anamnèse familiale
 - f. Vaccins, médicaments, allergies
2. Examens :
 - a. Aspect général : conscience, tonus muscu, contact
 - b. Respiration : position de l'enfant, travail respi,
 - c. Hémodynamique : changement des téguments, chauds froids
3. Croissance staturo-pondérale : âge et poids -> cinétique de la courbe -> si c'est un enfant qui suit bien sa courbe, c'est ok. Mais si casse sa courbe c'est pas normal.

4. Etat nutritionnel : enfants allaités jusqu'à 6 mois, introduction des aliments de sevrage de 3 à 6 mois, et donner des solides dès qu'il a des dents (6 mois)
 - a. Malnutrition : fatigue, peaux sèches, dents nécrosées, saignement gencive, ostéopénie -> fractures, troubles de l'attention, ballonnement abdos
 - b. Périmètre bras
 - c. Pli cutané
5. Status cardiaque :
 - a. Observer : extrémités, muqueuses (larmes, salives, hydratation), ongles, temps de recoloration
 - b. Ausculter : faire sur 30 secondes car ont parfois des arythmies à causes de la respiration
 - c. Souffles : fonctionnels car ont des fois le foramen ovale ouvert, ou sinon aussi pathologique
 - d. Toujours demander un ECG ou un US-doppler ou une radio du thorax
 - e. Palper : choc de pointe, frémissement précordial (patho), pouls périph (on ne sent pas sur les poignets chez les petits)
 - f. Insuffisance cardiaque :
 - i. Difficulté d'alimentation : fatigue pendant la tétée, durée, manque d'appétit
 - ii. Sudations, malaise
 - iii. Dyspnée, cyanose
 - iv. Poids, taille
6. Status pulmonaire
 - a. Observer
 - i. Dismorphisme, couleur, ongles, voix (rauque), types de toux
 - b. Détresse respiration (5) : tirage (trachéal, intercostal, supra-claviculaire), tachypnée, grunting, balancement thoraco-abdominal, battement des ailes du nez.
 - c. Fréquence pendant 1 minute
 - d. Obstruction des voies aériennes : voir petit tableau
 - i. Voies respi sup et inf
 - ii. 3 types de bruit :
 1. Grunting : très souvent pneumonie
 2. Bruits hauts transmis = sécrétions nasales
 3. Toux aboyante = larynx
7. Status neurologique
 - a. PC à terme = 35 cm, 45 à 8 mois
 - i. Si trop petits = lissencéphalie, trop gros = hydrocéphalie
 - b. Hypotonie :
 - i. Périph : aréflexie, faiblesse, fatigue musculaire
 - ii. Central : hypotonie axiale, léthargie, hyperéflexie, clonus, persistance des réflexes archaïques
 - c. Syndrome pyramidal = voies corticospinales, tous les mouvements volontaires
 - i. Signes de Babinski = positif, mais on ne dit pas s'il est négatif

ii. Hyperéflexies

8. Développement

- a. Sourire : 8 semaines
- b. Regard : 3 mois
- c. Objet : 5 mois
- d. 10 : assis sans appuis
- e. -...

9. Fièvre

- a. Température rectale plus que 38° -> enfant doit être déshabiller
- b. Inquiéter si enfant a plus de 5 jours de fièvre
- c. Souvent viral (rhume, gastro, otite, pharyngites)
- d. Signes de méningisme : irritabilité, raideur de nuque
- e. Essayer de trouver un foyer : toux, vomissement, diarrhée, rash
- f. Contage : crèche, entourage, voyages, vaccins
- g. Regarder tableau de quantifier de fièvre

10. Pleurs

- a. Patho que dans 5% des cas
- b. Anamnèse : type de pleur, depuis quand, retentissement, observation, déclenchement, alimentation, sommeil, transit
- c. Habituels ou excessifs ? proposer un agenda des pleurs
- d. S'inquiéter si l'enfant est en mauvaise état général, mauvais état
- e. Colique : 3h de pleurs par jours, >3j par semaine, >3 semaines. Cause inconnue -> rassurer les parents, soutenir ++. Légitimer leur vécu, favoriser l'allaitement et le portage, ils ont le droit de faire une pause, prévention du shaken baby. Mais commencer par s'assurer qu'il y a rien de grave.

11. Cas clinique : bob, 18 mois, rhinopharyngite depuis 3 jours, Maman décrit une respiration plus bruyante depuis hier soir.

- a. Anamnèse :
 - i. Fièvre ?
 - ii. Alimentation ?
 - iii. Hydratation ? On s'inquiète si boit moins de la moitié des quantités habituelles -> indication à hospitaliser pour réhydrater. Demander l'état des couches.
 - iv. Pleurs ?
 - v. Comportement ?
 - vi. Toux ?
 - vii. A avalé un corps étranger ?
- b. Status :
 - i. Constantes
 - ii. Faire d'abord le triangle
 - iii. ORL -> les bébés respirent que par le nez pendant leur 1^{ère} année

ECOS : vidéo du dvlp d'un enfant, regarder les stades et tout, courbes de croissance, faire une anamnèse avec la maman.

Status Pied et Cheville

Status bilatéral et comparatif

Bien savoir l'anatomie : interligne de Chopart (pour rotation externe et interne, amputations), interligne de Lisfranc (luxation). Loges des muscles. Ligaments (de la cheville bien savoir car font souvent des entorses. Le plus souvent c'est le talo-fibulo-antérieur). Vascularisation (savoir celles qu'on peut palper : tibial post (malléole INTERNE) et pédieux). Innervation.

1. Patient déshabillé (chaussures, chaussettes, pantalon)
2. Inspection :
 - a. Ecchymose : fracture, luxation, entorse, contusion
 - i. Règles d'Ottawa : si au moins un de ces point est positif, la proba qu'il y ait une fracture est assez haute -> faire une radio
 1. Palper les malléoles ext et int et remonter
 - b. Gonflement :
 - i. Global : chercher une fracture, donc palper un peu tout. Si c'est du calcanéum, c'est des gros choc alors aussi contrôler la colonne.
 - ii. Localisé : entorse (lig), muscles
 - iii. Pas de contexte traumatique :
 1. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs : stades
 2. Insuffisances veineuses : varices, œdème, dermite ocre, ulcération (car le sang va stagner et les toxines restent au niveau des tissus qui vont dégénérer)
 - c. Inflammation : érysipèle (staph ou strepto), engelure, Syndrome de Sudek (douloureux, allodynies, transpire plus au pied, motricité diminuée, œdèmes)
 - d. Hallux valgus
 - e. Polyarthrite rhumatoïde : symétrique, touche plutôt les IPP et pas les IPD
 - f. Difformité : fracture et luxations ?
 - g. Nodules
 - i. Au niveau du tendon d'Achille -> qui serait en souffrance
 - ii. Fibromatose plantaire : associé à putrène
 - h. Muscles : plâtre, déficit calorique, alité
 - i. Dermato : compression, artériopathie diabétique
 - j. Ongles : incarnés, infectieux, immuno
 - k. Si douleur intense, disproportionnée -> analgésique et morphine, a encore mal, si l'exa clinique a hyper mal -> syndrome des loges -> urgence chirurgicale sinon nécrose -> mesurer la pression dans les loges
 - l. Regarder l'arc qui sera bombé si luxation de Lisfranc
3. Examen :
 - a. Marche : sur la pointe de pied, talons, usure des shoes, points d'appuis
 - b. Podoscope :
 - i. Points d'appuis : voir s'il y a des points ou il y a plus de pression de d'autres, si diabétiques p.ex pourrait faire plus d'ulcérations

- c. Palpation :
 - i. Os et articulation :
 - 1. Malléoles et remonter le long du tibia, et si notion de traumatisme, palper tout le long de la fibula.
 - 2. Os du tarse : commencer en médial, et de plus en plus lat
 - ii. Insertions tendons et ligaments
 - iii. Tissus mous
 - iv. Pouls -> si on les as pas remonter les artères dans la jambe
 - 1. Malléole int
 - 2. Pédiéux
 - v. Points douloureux
 - vi. Température
- d. Mouvements : passifs et actifs -> demander si fait mal
 - i. Inversion et éversion
 - ii. Flexion et extension
- e. Examen neuro : Demander au patient de fermer les yeux, commencer le plus distal possible et s'il y a un problème remonter
 - i. Proprioception : monter ou descendre orteils
 - ii. Pallesthésie : malléole, genou, crête iliaque
 - iii. Sensibilité : toucher-piquer -> face médiale et latérale pour les 2 dermatomes
 - iv. Réflexes : achilléen et Babinski (jamais prévenir, et faire très fort)
- f. Manœuvre : Regarder si arrêts prolongés ou mous
 - i. Tiroir ant : test faisceau ant ligaments latéraux -> main sur talon ext et autre main tibia interne et tirer
 - ii. Talar tilt test
 - iii. Tapoter au niveau du passage du nerfs post (derrière la malléole) -> demander si fait mal
 - iv. Si a mal du la plante du pied, on peut suspecter une fascéite plantaire (obèses ou coureurs). Appuyer au milieu du pied qui est en extension.
 - v. Coucher à plat ventre, avec les pieds qui dépassent. Regarder comment les pieds tombent. Doit avoir un petit angle et pas vertical (serait rupturé). Malaxer le mollet et le pied va bouger, sinon c'est qu'il y a une rupture du tendon.

ECOS : cas classique : entorse. Faire les critères d'Ottawa et si un est positif il faut faire une radio, et aux urgences toujours faire une radio pour tout le monde.

Examen du rachis

Status mixte : ortho et neuro

- 1. Inspection : Patient debout, en sous-vêtements, le bras le long du corps, pieds nuls et à largeur du bassin : devant, de côté, de dos
 - a. Peau, tissus mous
 - b. Musculature

- c. Structures ostéo-articulaires
- d. Marche : pointes (S1), talons (L5) -> un déficit pourrait être causé par une hernie discale p.ex
- e. Toucher les crêtes iliaques
- 2. Palpation
 - a. Processus épineux : partie la plus post de la vertèbres -> chercher une douleur, une épine trop rentrée en dedans. Faire toutes les épines
 - b. Articulation sacro-iliaque : se positionner sur les épines iliaques postéro-sup, et continuer au milieu, appuyer et chercher des douleurs (là où il y a les fossettes des fesses). Surtout pour la recherche de spondylarthrite ankylosante.
 - c. Muscles paravertébraux : demander s'il y a des douleurs, si quelqu'un est bloqué est un peu penché sur le côté.
 - d. Percussion des vertèbres : taper sur sa main avec son poing et descendre le long de la colonne.
- 3. Mobilisation :
 - a. Cervical : bouger dans les 3 axes
 - b. Lombaire :
 - i. Flexion, mesure doigts-sol (N<20 cm). Regarder pour une scoliose, un côté sera plus haut que l'autre, différencie de la pseudo-scoliose.
 - ii. Test de Schobert : mesure C7 et 10 cm
 - c. Lombaire et thoracique : inclinaison, extension. Rotation : assis, bras en croix sur les épaules et demander de se tourner.
- 4. Neuro : dépend pas mal des demandes/douleurs : coucher le patient
 - a. Suspicion de radiculopathie lombaire :
 - i. Lasègue : lever la jambe, demander si fait une douleur particulière. Pas besoin d'aller très haut, 45°. Si on soulève une jambe et cela va faire mal dans l'autre -> caractéristique d'une hernie discale.
 - ii. Braguard : pareil mais mettre le pied en dorsiflexion et demander si la douleur réapparaît.
 - b. Recherche irritation du nerf fémoral :
 - i. Lasègue inversé : à plat ventre, lever la jambe qui est pliée et demander si fait mal.

Examen neuro du membre inférieur

Exa neuro général :

1. Etat mental
2. Nerfs crâniens
3. Motricité (coordination aussi)
4. Reflexes
5. Sensibilité
6. Autres tests (signes méningés, investigation radiculopathie,...)

Membre inf :

On peut presque tout faire couché

1. Marche : examine les systèmes moteurs, sensitifs et cérébelleux.
 - a. Marche : aller retour, pointes, talons, ballant des bras, funambule
 - b. Force des muscles proximaux
 - i. Assis et se lever sans les bras
 - ii. S'accroupir et se lever sans les bras
 - iii. Sautiller sur un seul pied ou faire des genuflexions
 - iv. Romberg : pieds collés et bras tendus, yeux ouverts et yeux fermés (20 sec). Si arrive déjà pas les yeux ouverts = Romberg positif -> problème cervelet. Et si arrive pas les yeux fermés -> systèmes vestibulaire, sensation des pieds.
 - v. Trendelenburg : rester debout et lever un pied, regarder si les hanches restent à la même hauteur.
2. Motricité -> faire toujours en miroir avec les 2 membres.
 - a. Inspection, palpation :
 - i. Palper les cuisses et jambe (soulever les membres) -> atrophie
 - b. Tonus
 - i. Hanche : bouger la cuisse
 - ii. Leg roll : Rouler la jambe comme un rouleau à pâte pour voir si la cheville oscille pas trop.
 - iii. Leg lift : soulever la jambe et laisser tomber. Si le talon vient avec, il y a trop de tonus.
3. Tests de forces -> savoir quelle fonction est relative à quelle racine.
 - i. Hanche : contre notre force : flexion, extension, abduction, adduction.
 - ii. Genou : Prendre appuis sur un genou et l'autre jambe par dessus
 - iii. Cheville et pied : Dorsiflexion (tirer le patient par les pieds), flexion plantaire, extension et flexion gros orteil, inversion/éversion.
 - iv. Mingazzini : épreuve des jambes fléchies. Maintenir la position pendant 20 sec.
 - v. Coordination :
 1. Talon-genou -> lever un talon bien haut dans l'air, le poser sur son genou et descendre le long du tibia jusqu'à la cheville.
 2. Mouvements rapides des pieds : taper vite avec le pied (contre notre main ou par terre)
4. Réflexes :
 - a. ROT :
 - i. Patellaire
 - ii. Achilléen

- b. Clonus cheville : surtout si les réflexes sont hypervifs. Bouger un peu la cheville pour la détendre, et brusquement la mettre en dorsiflexion, maintenir quelques secondes et regarder si fait des oscillations
 - c. Cutané plantaire : Babinski
- 5. Sensibilité
 - a. Toucher-piqué : touché (épicritique) et toucher (spinothalamique) -> remonter si on a pas
 - b. Pallesthésie : gros orteil, malléole interne -> si c'est ok pas besoin de remonter
 - c. Proprioception : tenir le pouce sur le côté, écarter les autres orteils et demander si monte ou descend.
- 6. Racines lombaires : recherche radiculopathie
 - a. Lasègue
 - b. Braguard

ECOS : jeune patient avec trouble de la sensi au niveau inf : faites un status neuro ciblé -> faire toucher piquer, proprioception, pallesthésie, Lasègue, Romberg, marche du funambule.

Epaule

Faire un exa bilatéral, comparer actif et passif, goniomètre -> mesurer les angles.
Faire les tests spécifiques.

Coiffe des rotateurs : subscapulaire, infra-épineux, petit rond, supra-épineux

- 1. Inspection
 - a. Cutané
 - b. Position des structures
 - c. Attitude antalgique
 - d. Trophicité musculaire
- 2. Palpation
 - a. Toutes les structures jusqu'au sternum
 - b. Palper les tendons aussi -> gouttière bicipitale
 - c. Température et sensibilité
 - d. Douleurs
 - e. Test de la laxité des ligaments :
 - i. Tests de laxité ant et post : mettre la main sur l'épaule et le coude et regarder si vient avec ou pas
 - ii. Test d'appréhension ant et post : si le patient a peur de ce qu'on va faire, souvent si a eu un antécédent de luxation.
Mettre son bras en mode à 90° et appuyer sur humérus.
- 3. Amplitudes articulaires : avec goniomètre actif et passif
 - a. Flexion
 - b. Extension
 - c. Adduction

- d. Abduction
 - e. Rotation externe
 - f. Rotation interne : mains dans le dos et pousser (pas besoin du gonio)
4. Force musculaire :
- a. Supra épineux -> lever les bras à 90°, les avancer à 30° et mettre les pouces en bas, ensuite appuyer dessus et doit lâcher si déchirure du muscle
 - b. Petit rond : mettre bras à 90° et pousser en arrière -> manœuvre de Patte ou signe du clairon -> mettre la main devant la bouche, et si lève l'épaule est patho (coude à la même hauteur de la main)
 - c. Sous-épineux : bras à 90° mais coudes collés, résister contre la rot ext. Signe du portillon, signe du clairon (fait pas très bien la différence entre petit rond et supra épineux)
 - d. Sous-scapulaire : Belly-press test -> regarder le coude -> si les mets trop en avant ou en arrière pour appuyer c'est patho. Lift-off -> si arrive pas à lever les mains.
 - e. Conflit sous-acromial : bourse qui peuvent être enflammées qui bloquent le mouvement.
 - i. Test de Neer : passif, lever le bras du patient devant, et s'il a mal = test positif. Si dit qu'il a mal, demander de faire une supination, et doit faire moins mal si c'est une bursite.
 - ii. Test de Hawkins : prendre le bras plié et le jeter en avant -> doit faire mal
 - f. Biceps brachial : Palm up -> appuyer contre les mains (coudes pliés). Test de Yergason : essayer de faire une supination contre résistance. On peut aussi appuyer sur la gouttière pendant qu'on fait le test.

Coude

- 1. Observation : doit être en valgus
- 2. Palpation :
 - a. Epicondyles
 - b. Insertions ligamentaires
 - c. Tinel : tapoter
 - d. Durkan : manœuvre : comprimer pendant 30 sec et si fait mal = compression du nerf ulnaire
- 3. Mouvements :
 - a. Flexion et extension, faire attention si fait mal au niveau des épicondyles = épicondylites.
 - b. Signes de Froment : tirer sur une feuille -> nerf ulnaire

Genou

- 1. Observation :
 - a. Trendelenburg : si lève la jambe gauche la patho est à droite.

- b. Gowers : accroupis arrive pas à se lever sans les mains, parésie des muscles proximaux -> Myopathie de Duchenne
 - c. Varus et valgus
 - d. Cutané
 - e. Luxation de la rotule (toujours latéral)
 - f. Amplitude antalgique
 - g. Trophicité musculaire
 - h. Longueur et symétrie des MI
- 2. Palpation :
 - a. Interligne articulaire -> difficile à la trouver coucher, donc plier la jambe (c'est assez bas)
 - b. Patella (laxable ?)
 - c. Insertions tendineuses et ligamentaires
 - d. Creux poplitée (kyste de Baker)
 - e. Température et sensibilité
 - f. Douleurs
 - g. Signe du glaçon : épanchement dans la cavité articulaire ?
- 3. Amplitudes articulaires
 - a. Pieds qui va toucher la fesse : mesurer distance talon-fesse.
 - b. Tendre la jambe et mesurer l'angle -> recurvatum ?
 - c. Observer la position de repos quand est debout pour le recurvatum
- 4. Appareil ligamentaire :
 - a. Latéraux : en extension à 30° il doit pas bouger
 - b. Croisés : Tiroir ant et post (flexion à 90°) + Lachman -> décrire arrêt (dur ou mou) et course (normale ou augmentée, c'est la distance que l'on parcourt)
 - c. Ménisques :
 - i. McMurray : lever le genou et bouger la cheville dans tous les sens et demander si fait mal.
 - ii. Apley test : sur le ventre, lever la jambe, et tourner le pied en ext et appuyer pour le ménisque interne. Si a déjà mal sans appuyer c'est plutôt les ligaments et pas les ménisques. Pour tester le ménisque ext tourner le pied à l'int
 - iii. Childress test : debout, fléchir sur un pied, va faire mal
 - iv. Ménisque en anse de seau : la partie déchirée va coincé au niveau du fémur et ne peut plus faire une extension du tout -> CHIR pour resuturer le ménisque

Hanche

- 1. Observer
 - a. Position antalgique : soit fléchis la jambe, soit fait une hyperlordose
- 2. Palpation : grand trochanter et un peu autour -> bursite
- 3. Mouvement :
 - a. Flexion : coller le plus possible le genou au torse (actif et passif)

- b. Rotation interne et externe en bougeant le genou qui est plié. Douleur en rot int (on tourne la jambe vers l'ext)= premier signe d'arthrose.
 - c. Abduction : main sur la hanche opposée car au bout d'un moment, toute la hanche va se déplacer, et on peut le sentir. Mesurer l'angle avant que tout le bassin bouge.
- 4. Examen rhumatologique
 - a. Test de Faber = signe du 4 : pied sur genou -> si fait mal = spondylarthrite ankylosante
 - b. Couché, une jambe sur le lit et l'autre tombe, et lever le genou contre le thorax, si fait mal = spondylarthrite ankylosante